

心理护理在老年慢性阻塞性肺疾病患者护理中的应用效果及对患者焦虑 抑郁情绪的影响

张 俊

资溪县人民医院, 江西 抚州 335300

【摘要】目的 探讨心理护理对老年慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)患者的影响。方法 纳入2022年8月—2024年8月收治的62例老年COPD患者,随机分为2组,各31例。对照组行常规护理,观察组在对照组基础上行心理护理,比较2组患者护理差异。结果 护理后,观察组焦虑自评量表(self-rating anxiety scale, SAS)评分为 (26.74 ± 2.04) 分、抑郁自评量表(self-rating depression scale, SDS)评分为 (29.48 ± 3.32) 分,低于对照组的 (36.58 ± 2.66) 分、 (36.47 ± 3.60) 分($P < 0.05$)。护理后,观察组生理功能评分为 (81.91 ± 5.46) 分、心理功能评分为 (88.36 ± 6.32) 分、社会功能评分为 (88.12 ± 6.26) 分,高于对照组的 (71.68 ± 4.31) 分、 (77.13 ± 5.26) 分、 (83.15 ± 5.59) 分($P < 0.05$)。护理后,观察组1秒率为 $(78.42 \pm 5.51)\%$ 、最大呼气峰流速(peak expiratory flow, PEF)为 $(93.43 \pm 4.12)\%$ 、第1秒用力呼气容积(forced expiratory volume in the first second, FEV₁)为 (2.97 ± 0.30) L,高于对照组的 $(69.18 \pm 4.73)\%$ 、 $(84.57 \pm 5.25)\%$ 、 (2.29 ± 0.27) L($P < 0.05$)。结论 对于老年COPD患者,采取适当的心理护理至关重要,有助于缓解患者焦虑、抑郁情绪,有效增强患者肺功能,改善患者整体生活质量。

【关键词】心理护理;老年;慢性阻塞性肺疾病;焦虑;抑郁

文章编号: 1672-1721(2025)12-0147-03

文献标志码: A

中国图书分类号: R473.5

COPD通常与长期接触烟草烟雾、空气污染等有害物质有关^[1]。研究显示,COPD患者广泛存在焦虑、抑郁等心理障碍,加重患者生理症状,影响治疗效果和康复进程^[2]。心理护理是整体护理策略中不可或缺的一部分,对于老年COPD患者而言尤为重要。心理护理通过细致评估患者的心理状态,制定和实施个性化的心理干预措施,旨在有效减轻或消除患者负性情绪,提高患者面对疾病的心理承受力,提升患者整体健康水平,改善患者生活质量和治疗结果^[3]。近年来,有关心理护理在COPD患者护理中的应用及对患者心理健康影响的研究日益丰富^[4]。本研究选取2022年8月—2024年8月收治的62例老年COPD患者作为研究对象,探究心理护理对COPD患者的影响,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2022年8月—2024年8月收治的62例老年COPD患者,随机分为2组,各31例。对照组男性19例,女性12例;年龄62~84岁,平均

年龄 (74.45 ± 1.77) 岁;病程2~13年,平均病程 (7.36 ± 0.79) 年。观察组男性18例,女性13例;年龄61~82岁,平均年龄 (73.90 ± 1.51) 岁;病程2~12年,平均病程 (7.29 ± 0.89) 年。2组患者的一般资料比较,差异无统计学意义($P > 0.05$),有可比性。患者及其家属知情并签署知情同意书。

1.2 入选标准

纳入标准:符合COPD的诊断标准;年龄 ≥ 60 岁;具备清晰的自我意识,能与护理人员有效沟通,理解力正常;医疗记录完整真实。

排除标准:存在严重疾病、免疫缺陷或感染;伴有其他重要器官病变;患有精神障碍或认知异常;依从性不佳;病情不稳定。

1.3 方法

1.3.1 对照组护理方法

对照组采用常规护理。针对处于急性期的患者,应提供24h的病情监测,给予持续吸氧治疗,叮嘱患者注重保暖。针对病情进入稳定期后的患者,建议患者停止吸烟、饮酒,调整生活习惯,增加适度的体育活动,改善健康状况。饮食方面,

作者简介:张俊(1988—),女,江西资溪人,本科,主管护师,主要从事外科护理方面的研究。

推荐减少糖分和盐分的摄入。指导患者进行腹式呼吸练习，并向患者普及 COPD 相关知识，确保患者正确理解药物使用方法。

1.3.2 观察组护理方法

观察组在对照组基础上行心理护理。(1) 缓解焦虑情绪。患者入院初期，医护人员应当以热情的态度接待患者，并详细向患者介绍住院流程、手术目的及重要性。实施护理措施前，评估患者心理状态，确保患者充分了解整个治疗过程，提高患者配合度。指导患者掌握正确的呼吸技巧，减轻患者生理上的不适，缓解患者紧张与焦虑情绪。护士在与患者交流时应采用温和的语气，提供适当的情感支持，强调积极面对疾病的重要性，增强患者信心。(2) 同伴支持。鼓励建立患者互助网络，定期组织小组会议或活动，邀请恢复良好的患者分享经验，为其他患者树立正面榜样，激发患者战胜疾病的信心。同时，指导患者运用自我调节技巧，比如听音乐、阅读或者冥想等方法，帮助患者更好地管理自身情绪状态。(3) 家庭支持。医护人员需以专业且友好的态度，主动与患者家属沟通，帮助患者家属理解如何给予患者最有效的支持，使患者家属认识到自己的情绪对患者的影响，提倡患者家庭成员之间保持开放性、支持性的对话环境。建议患者家庭成员参与到患者的康复过程中，展示康复案例视频或励志文章，传递正面的信息内容，提升患者对抗疾病的勇气和信念。(4) 沟通频率。加强医生与护士之间的协作，确保信息的一致性和准确性。日常工作中，护士应增加与患者的互动次数，每日查房时需注意观察并记录患者的精神状况，及时发现患者潜在的心理问题。针对识别出的具体心理困扰，分析背后原因，采取相应的干预措施，如提供心理咨询或转介至专业心理服务等。(5) 出院后随访。出院

后，医疗机构可通过电话访问、电子邮件或社交媒体等多种方式维持与患者的联系。利用微信公众号等平台发布关于心理健康维护和肺功能恢复的相关知识，鼓励患者积极参与学习。设立线上交流群组，便于患者间进行信息共享和个人健康管理经验的交流。定期举办在线讲座或工作坊，进一步促进患者群体的知识更新和个人能力的发展。

1.4 观察指标

比较 2 组患者心理情绪、生活质量、肺功能指标。(1) 心理情绪。采用 SAS、SDS 评估 2 组患者护理前后心理情绪，得分越高表明患者抑郁、焦虑情绪越严重。(2) 生活质量。采用生活质量简表评估 2 组患者护理前后生活质量，总分 0~100 分，得分越高表明患者生活质量越好。(3) 肺功能指标。比较 2 组患者护理前后肺功能指标水平，包括 1 秒率、PEF、FEV₁。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计学软件分析数据。符合正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示，行 t 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 心理情绪

护理后，观察组 SAS、SDS 评分低于对照组，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，见表 1。

2.2 生活质量

护理后，观察组生活质量评分高于对照组，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，见表 2。

2.3 肺功能指标水平

护理后，观察组肺功能指标 (1 秒率、PEF、FEV₁) 水平高于对照组，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)，见表 3。

表 1 2 组患者护理前后 SAS、SDS 评分比较 ($\bar{x} \pm s$) 单位：分

组别	例数	SAS 评分		SDS 评分	
		护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	31	51.49 ± 4.06	26.74 ± 2.04	53.58 ± 4.14	29.48 ± 3.32
对照组	31	52.47 ± 4.11	36.58 ± 2.66	53.59 ± 4.13	36.47 ± 3.60
t 值		-0.944	-16.578	-0.010	-7.947
P 值		0.349	<0.001	0.992	<0.001

表 2 2 组患者护理前后生活质量评分比较 ($\bar{x} \pm s$)

单位：分

组别	例数	生理功能		心理功能		社会功能	
		护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	31	61.37 $\pm$ 3.33	81.91 $\pm$ 5.46	60.90 $\pm$ 3.25	88.36 $\pm$ 6.32	63.96 $\pm$ 4.59	88.12 $\pm$ 6.26
对照组	31	61.38 $\pm$ 3.30	71.68 $\pm$ 4.31	60.91 $\pm$ 3.24	77.13 $\pm$ 5.26	64.01 $\pm$ 4.46	83.15 $\pm$ 5.59
<i>t</i> 值		-0.012	8.188	-0.012	7.604	-0.043	5.297
<i>P</i> 值		0.991	<0.001	0.990	<0.001	0.965	0.002

表 3 2 组患者护理前后肺功能指标水平比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	1 秒率 /%		PEF/%		FEV ₁ /L	
		护理前	护理后	护理前	护理后	护理前	护理后
观察组	31	63.23 $\pm$ 4.65	78.42 $\pm$ 5.51	75.60 $\pm$ 4.73	93.43 $\pm$ 4.12	1.42 $\pm$ 0.27	2.97 $\pm$ 0.30
对照组	31	63.22 $\pm$ 4.54	69.18 $\pm$ 4.73	76.16 $\pm$ 4.65	84.57 $\pm$ 5.25	1.46 $\pm$ 0.19	2.29 $\pm$ 0.27
<i>t</i> 值		0.009	7.085	-0.470	7.392	-0.675	9.381
<i>P</i> 值		0.993	<0.001	0.640	<0.001	0.503	<0.001

3 讨论

近年来, COPD 作为一种以肺部炎症反应为特征的疾病, 是呼吸科常见的气管功能障碍性疾病。COPD 为进展性呼吸系统疾病, 发病原因包括空气质量、环境条件、生活方式、职业暴露及感染等^[5]。老年 COPD 患者发病后, 轻则表现为持续性咳嗽、咳痰、呼吸急促等症状, 影响日常生活; 重则可能导致严重呼吸困难, 威胁患者生命安全^[6]。临床治疗 COPD 主要依赖药物控制, 但对于急性加重期患者, 往往需要借助呼吸机支持以维持基本呼吸功能。在此期间, 有效的护理干预措施对于减少并发症的发生和改善治疗效果起到至关重要的作用。

本研究结果显示, 护理后, 观察组的 SAS 评分为 (26.74 $\pm$ 2.04) 分、SDS 评分为 (29.48 $\pm$ 3.32) 分, 低于对照组的 (36.58 $\pm$ 2.60) 分、(36.47 $\pm$ 3.60) 分, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。心理干预旨在促进患者树立正面心态, 使患者能够以积极思维模式应对消极观念, 增强患者的康复信心和对生活的积极态度。积极情感的运用有助于减轻患者治疗过程中的心理压力, 减少消极情绪, 提高其适应能力和恢复力。患者之间的交流活动, 能为患者提供分享经验和情感支持的平台, 构建互相鼓励、共同面对挑战的社区环境, 有助于患者更准确地认识疾病, 有效地规划和建

立个人健康行为, 减轻因疾病造成的心理压力。通过建立同伴支持系统, 采用榜样激励的方式, 可以在精神层面上给予患者重要的支持, 帮助患者建立积极的生活态度, 促进身心健康恢复。本研究结果显示, 护理后, 观察组生理功能评分为 (81.91 $\pm$ 5.46) 分、心理功能评分为 (88.36 $\pm$ 6.32) 分、社会功能评分为 (88.12 $\pm$ 6.26) 分, 高于对照组的 (71.68 $\pm$ 4.31) 分、(77.13 $\pm$ 5.26) 分、(83.15 $\pm$ 5.59) 分, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。护理后, 观察组 1 秒率为 (78.42 $\pm$ 5.51) %、PEF 为 (93.43 $\pm$ 4.12) %、FEV₁ 为 (2.97 $\pm$ 0.30) L, 高于对照组的 (69.18 $\pm$ 4.73) %、(84.57 $\pm$ 5.25) %、(2.29 $\pm$ 0.27) L, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。加强与患者的沟通, 深入了解患者消极情绪的根源, 提供针对性心理支持, 改善患者情绪状态, 增强患者自我效能感和自我控制能力, 提高患者参与肺功能康复训练的积极性, 从而加速患者肺功能恢复。随着肺功能的逐步改善, 患者在日常生活中的受限程度减少。在出院后的随访过程中, 利用微信等平台定期向患者提供 COPD 相关内容, 可以有效激发患者主动参与疾病管理的积极性。

综上所述, 对老年 COPD 患者采取适当的心理护理有助于缓解其焦虑、抑郁情绪, 有效增强患者肺功能, 从而改善患者整体生活质量。

(下转第 156 页)

业、连贯的指导和服务^[14-15],通过定期认知教育、线上答疑、督促用药、跟踪调查及记录等方式,能够不断加深患者对疾病与自身病情的了解,帮助患者培养科学的饮食、用药与生活行为,增强患者的自我护理能力;延续性护理注重对患者心理情绪的了解和疏导,能够引导患者端正心态,

正确对待疾病,促使患者以积极、主动的态度配合护理,更自觉服药,进而更有效管理自身病情,提升生活质量。

综上所述,延续性护理能够有效调节慢性乙型肝炎患者的心态,增强患者的自护能力,提高其服药依从性,改善其生活质量。

参考文献

- [1] 张文芸,王园园,孙岳.聚焦解决护理干预模式对于慢性乙型肝炎患者依从性和自我护理能力的改善价值[J].国际护理学杂志,2024,43(2):193-197.
- [2] 谢海霞,秦晓娟,刘淑娟.基于微信平台的延续性护理联合认知护理在慢性乙型肝炎患者中的应用[J].中西医结合护理(中英文),2022,8(11):115-117.
- [3] 程金红,林灵敏,许春柳,等.基于微信平台的延续护理干预对慢性乙型肝炎患者自我效能及治疗依从性的影响[J].齐齐哈尔医学院学报,2021,42(1):76-78.
- [4] 中华医学会肝病学会,中华医学会感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)[J].中华肝脏病杂志,2022,30(12):1309-1331.
- [5] 段泉泉,胜利.焦虑及抑郁自评量表的临床效度[J].中国心理卫生杂志,2012,26(9):676-679.
- [6] 郭丽娜,刘莹,郭启云,等.中文版老年人自我护理能力量表的信效度研究[J].中华护理杂志,2015,50(8):1009-1013.
- [7] 刘怡均,林向英,张燕.中文版世界卫生组织生存质量测定量表简表用于终末期肾病的信效度验证[J].首都医科大学学报,2021,42(4):635-641.
- [8] 魏媛.医院-社区-家庭三位一体无缝护理模式对慢性乙型肝炎患者抗病毒治疗依从性、自护效能的影响[J].基层医学论坛,2023,27(15):96-98.
- [9] 李颖婷,邓玉洁.基于症状控制的层级护理在慢性乙型肝炎活动期病人中的应用探讨[J].循证护理,2023,9(8):1468-1472.
- [10] 李红燕,赵艳艳,窦侠玲,等.基于移动平台的专业化个案管理模式在慢性乙型肝炎患者延伸护理效果探究[J].实用医学研究,2023,5(4):61-64.
- [11] 李汝珂,赵巍峰.延续性护理对慢性乙型肝炎及肝硬化患者服用核苷(酸)类药物的效果分析[J].中国药物滥用防治杂志,2022,28(6):805-808,816.
- [12] 王君,欧阳滢,宋晶晶.延续性护理在慢性乙型肝炎患者中的应用效果[J].中国民康医学,2020,32(14):160-162.
- [13] 王光霞.延续性护理干预对慢性乙肝患者治疗依从性和自护能力的影响[J].河南医学研究,2020,29(6):1123-1124.
- [14] 邓俊黎,肖银芬,张霓.延续性护理对初诊慢性乙型肝炎患者的干预效果[J].中西医结合护理(中英文),2021,7(7):109-111.
- [15] 蒲慧明,任艳叶.基于奥马哈系统理论的延续性护理结合积极心理干预对慢性乙型肝炎患者疾病自我感受负担及疾病控制的影响[J].临床医学研究与实践,2024,9(3):150-153.

编辑:许 琪

(上接第149页)

参考文献

- [1] 胡玉玲,王敏.心理护理对老年慢阻肺患者的效果[J].国际精神病学杂志,2022,49(6):1120-1123.
- [2] 李岩,王冠东,李文娟,等.心理护理联合无创呼吸机干预对慢性阻塞性肺疾病合并呼吸衰竭患者的效果[J].国际精神病学杂志,2023,50(5):1219-1222.
- [3] 李韦.视频健康教育结合积极心理护理对慢性阻塞性肺疾病患者心理状态、康复依从性、功能恢复的影响[J].临床与病理杂志,2022,42(11):2812-2820.
- [4] 王海红,朱锦梅.精细化护理干预对慢性阻塞性肺疾病患者肺功能及心理状态的影响[J].贵州医药,2023,47(11):1830-1832.
- [5] 张敏青,徐方方,任君梅,等.预见性护理干预在慢性阻塞性肺疾病患者中的实施价值探讨[J].基层医学论坛,2022,26(5):105-107.
- [6] 赵俊.新型冠状病毒肺炎疫情期慢性阻塞性肺疾病患者心理护理干预效果评价[J].中国药物与临床,2020,20(24):4193-4195.

编辑:郭晓添